



'이것만은 꼭 기억하세요'

- 아토피피부염은 피부에 가려움증을 동반한 염증이 생겨 오랜 시간 호전과 악화를 반복하는 질환입니다. 알레르기 비염, 알레르기 결막염, 천식 등과 함께 대표적인 알레르기 질환 중 하나이며, 대개 생후 2~3개월부터 나타나고 많은 경우 성장하면서 증상이 나아집니다.
- 아토피피부염은 유전적인 요인이 있어 가족 중에 아토피 질환이 있는 경우 발생 가능성이 높습니다. 피부 장벽 기능의 저하와 피부 면역 세포들의 외부 알레르기 물질에 대한 과민한 반응이 복합적인 원인으로 작용합니다. 대기 오염 및 환경 변화 외에 정신적 스트레스도 아토피피부염의 원인이 될 수 있습니다.
- 아토피피부염이 생긴 부위에는 심한 가려움증, 붉은 반점, 물집, 부종, 진물, 딱지 등이 나타날 수 있습니다. 피부를 반복적으로 긁으면 가려움증이 더 심해지며, 시간이 지남에 따라 피부가 거칠고 두꺼워지며 질게 착색될 수 있습니다.
- 아토피피부염은 증상의 심한 정도에 따라 치료법이 달라집니다. 대개 바르는 치료제를 사용해 가려움증과 염증을 감소시킬 수 있지만, 바르는 치료로 나아지지 않는 경우에는 먹는 약, 주사제, 자외선 치료 등을 사용해볼 수 있습니다.
- 아토피피부염의 예방 및 관리를 위해서는 피부염을 악화시키는 알레르기 요인들을 피하고, 실내 온도(20~22℃)와 습도(45~55%)를 적정 수준으로 유지하며, 피부를 잘 씻고 보습제를 사용해 피부가 건조하지 않도록 하는 것이 중요합니다. 적절한 운동 및 친밀한 대상과의 대화 등을 통해 스트레스를 해소해 정서적으로 안정적인 상태를 유지하는 것도 중요합니다.

요약문

개요

아토피피부염은 호전과 악화를 반복하며 오래 지속되는 염증성 피부 질환입니다. 대개 생후 2~3개월부터 나타나며, 심한 가려움증과 반복되는 피부 염증이 생깁니다. 영아기의 아토피피부염은 얼굴의 붉은 발진으로 시작되는 경우가 많습니다. 가려움으로 인해 병변 부위를 긁거나 문지르게 되는데, 그 결과 피부 증상이 더욱 악화되는 것이 특징입니다. 아토피피부염은 수면 장애, 감정적·신체적 스트레스를 일으키고 사회생활에도 방해가 됩니다. 이로 인해 삶의 질이 떨어지고 경제적 손실도 생기며, 환자의 가족, 나아가 사회에도 큰 비용 부담으로 이어지는 사회 공동체의 문제이기도 합니다.

개요-정의

아토피(atopy)는 '이상한' 또는 '부적절한'이라는 뜻의 그리스어에서 유래한 단어로 유전적인 성향이 있으며, 특정 환경 요인에 대해 피부의 면역계가 과민한 반응을 보이는 질환을 말합니다. 아토피 질환에는 아토피피부염뿐 아니라 천식, 알레르기 비염, 알레르기 결막염 등이 포함됩니다.

개요-원인

아토피피부염의 원인에 대해 많은 연구가 진행되어 왔으나, 지금까지도 원인이 완전히 밝혀지지 않았습니다. 아토피피부염은 유전적인 소인과 면역학적 이상, 피부 보호막 역할을 하는 피부 장벽 기능의 이상 등 여러 요인의 복잡한 상호 작용에 의해 발생한다고 생각합니다.

1. 유전적 소인

아토피피부염 환자의 70~80%에서 아토피피부염, 알레르기 비염, 천식 등 아토피 질환의 가족력을 확인할 수 있으며, 가족 중에 아토피 질환이 있는 경우 아토피피부염의 발생 가능성이 높습니다. 부모 중 한쪽에 아토피피부염이 있는 경우 발생할 확률이 높으며, 부모 모두 아토피피부염이 있는 경우 확률이 더욱 높아집니다. 쌍둥이의 아토피피부염 동반율을 비교한 연구에 따르면, 일란성 쌍둥이의 경우 72%에서 동시에 아토피피부염을 보이는 반면, 이란성 쌍둥이는 23%에서 동시에 아토피피부염을 보입니다. 아토피피부염의 유전 양식과 원인 유전자는 아직 정확히 밝혀지지 않았으며, 피부 장벽 기능과 면역에 관련된 다인자 유전으로 생각합니다. 대표적인 유전자 변이 연구 결과, 피부 장벽에 중요한 역할을 담당하는 단백질인 필라그린 유전자(FLG)의 기능 결함 돌연변이가 아토피피부염 및 이와 동반된 천식의 발생과 밀접한 연관 관계가 있음을 확인했습니다.

2. 면역학적 이상

피부에는 외부의 다양한 물질을 방어하는 면역 기능이 있습니다. 아토피피부염에서는 알레르기 반응에 관여하는 면역 세포들이 알레르기 원인 물질에 대해 비정상적인 과민 반응을 보이며, 이때 여러가지 염증 유발 물질이 만들어져 피부 증상이 나타납니다.

3. 피부 장벽 기능의 이상

피부는 외부의 해로운 자극이나 병원균으로부터 우리 몸을 보호하고, 수분 손실을 방지하는 보호막 역할을 합니다. 피부 장벽 기능에 이상이 생기면 피부를 통해 수분이 소실되기 쉬워져 건조증이 나타납니다. 건조증이 있는 피부는 알레르기 항원이 침투하기 쉽고, 세균 및 바이러스 감염에 취약한데, 이러한 감염이나 알레르기 반응은 아토피피부염을 일으키거나 악화시킬 수 있습니다.

4. 환경적 요인

핵가족화와 주거환경 개선에 따른 개인 위생 변화, 유해화학물질 사용 확대, 산업화에 따른 환경오염물질 증가, 영유아기 항생제 사용 증가 등이 아토피피부염의 발생에 영향을 미친다고 생각합니다.

개요-경과 및 예후

아토피피부염은 57%의 환자에서 생후 1년 이내, 87%에서 생후 5년 이내에 시작되며, 영유아기에 시작된 아토피피부염은 대개 성장하면서 증상이 호전됩니다. 하지만 최근 보고에 의하면 성인이 되어서도 증상이 지속되거나, 성인기에 새로 발생하는 경우도 많습니다.

역학 및 통계

아토피피부염은 주로 영유아기에 발생하는 만성 염증성 피부염이지만 성인기까지 지속되거나 성인기에 새로 발생할 수도 있습니다. 나라마다 아토피피부염의 유병률은 차이가 있지만 세계적으로 증가 추세로, 서구화된 국가에서 어린이는 10~20%, 성인은 3~7%의 유병률을 보입니다. 우리나라에서도 어린이의

10~20%, 성인의 1~3% 정도가 아토피피부염을 겪는 것으로 추정되며, 지역, 연령, 성별, 사회 문화적 특성에 따라 다양한 유병률을 보입니다. 유병률 증가의 원인은 충분히 밝혀지지 않았으나 위생 가설, 실내외 대기 오염, 기후 요인, 주거 환경 변화로 인한 항원 노출 증가, 영유아기 항생제 사용 증가, 서구화된 생활 방식, 비만, 스트레스 증가 등이 복합적으로 작용한다고 생각합니다. 위생 가설이란 산업화된 사회에서 가족 구성원의 감소, 주거 환경 및 개인 위생의 개선으로 유아가 바이러스 및 세균 감염이 줄어들어 아토피 질환의 유병률이 증가한다는 가설입니다. 최근에는 미세먼지와 아토피피부염의 관련성이 증명되기도 했습니다.

증상

아토피피부염의 주요 특징은 심한 가려움증과 외부 자극 혹은 알레르기 유발 물질에 대한 과민한 반응입니다. 가려움증은 아토피피부염의 가장 흔한 증상으로 습도의 변화, 알레르기 항원 노출, 과도한 땀 분비, 스트레스, 자극 물질 노출 등에 의해 악화될 수 있으며, 특히 밤에 심해져서 수면을 방해하고 삶의 질을 떨어뜨립니다. 또한 피부를 긁으면 피부 증상이 악화되어 가려움증이 더욱 심해지는 악순환을 반복하게 됩니다.

아토피피부염 환자의 피부는 건조하고 윤기가 없으며, 겨울에는 건조증이 더 악화됩니다. 피지 분비는 정상이지만 지질(세라마이드) 성분에 이상이 있기 때문입니다. 건조증이 있는 피부는 피부 장벽 기능이 약해져 수분이 쉽게 소실되며, 외부의 자극 물질이 쉽게 침투할 수 있습니다.

급성기에는 가려움증이 심한 붉은 반점, 물집, 긁은 자국, 진물이 나타나며 이차 감염이 동반될 수 있습니다. 급성기 이후에는 긁은 상처와 각질 등이 생기고, 만성기에 접어들면 반복적으로 피부를 긁은 결과 피부가 거칠고 두꺼워지며 피부 주름이 뚜렷해지는 태선화 현상과 함께 심하게 가려운 붉은색이나 갈색 결절이 발생할 수 있습니다.

아토피피부염의 임상 양상과 분포는 나이에 따라 달라지는데, 보통 유아기(생후 2개월~2세), 소아기(2세~10세), 청소년기와 성인기로 분류합니다.

1. 유아기: 주로 생후 2~3개월 이후에 급성 병변으로 양 볼에 홍반이 나타납니다. 이마, 두피와 팔다리의 편부위에도 병변이 잘 생깁니다. 유치가 날 때나 감기, 예방 주사에 의해 증상이 악화될 수 있습니다.

2. 소아기: 소아기 아토피피부염은 팔다리의 접히는 부위(팔꿈치 앞, 오금부)와 목에 주로 나타납니다. 엉덩이, 눈꺼풀 주위, 손목, 발목에도 잘 나타나며, 귓볼 주변 피부가 찢어지고, 진물이 나거나 딱지가 생깁니다. 입술염이 흔하며, 특히 윗입술에 잘 생깁니다. 증상이 지속되면 점차 피부가 두꺼워지고 피부색이 짙어집니다.

3. 청소년기/성인기: 소아기와 비슷하게 팔다리의 접히는 부위에 나타나며, 얼굴, 목에도 잘 나타납니다. 피부가 두꺼워지는 태선화 등 만성 증상이 흔합니다. 목 부위가 때가 낀 것처럼 지저분하게 보일 수 있으며, 손의 만성 습진이나 유두 습진이 발생할 수 있습니다.

진단 및 검사

아토피피부염은 한두 가지의 검사를 통해서가 아니라 임상 증상과 병력 조사, 검사 소견을 종합해서 진단합니다. 우리나라에서는 대한아토피피부염학회에서 한국인의 특징적인 임상 양상을 고려한 진단 기준을 마련해 사용하고 있습니다.

1. 아토피피부염의 진단

2005년 대한아토피피부염학회에서는 한국인의 아토피피부염 진단 기준을 아래와 같이 제시하였습니다. 3가지 주 진단 기준 중 2가지 이상과 14가지 보조 진단 기준 중 4가지 이상이 나타난 경우 아토피피부염으로 진단합니다.

1) 한국인의 아토피피부염 진단 기준

① 주 진단 기준

- ° 가려움증
- ° 특징적인 피부염의 모양 및 부위
- 2세 미만의 환자: 얼굴, 몸통, 팔다리가 퍼지는 부위의 습진
- 2세 이상의 환자: 얼굴, 목, 팔다리가 접히는 부위의 습진
- ° 아토피 질환(아토피피부염, 천식, 알레르기 비염)의 과거력이나 가족력

② 보조 진단 기준

- ° 피부 건조증
- ° 백색 잔비늘증(백색 비강진, pityriasis alba)
- ° 눈꺼풀 피부염 및 눈 주위의 어두운 피부
- ° 귀 주위 습진
- ° 입술염
- ° 손, 발의 비특이적인 습진
- ° 두피의 비늘
- ° 모공 주위 피부의 두드러짐
- ° 유두 습진
- ° 땀이 날 때 가려움증 동반
- ° 백색 피부 그림증(백색 피부 모기증, white dermographism)
- ° 즉시형 피부 반응 양성(단자 검사 양성 반응)
- ° 혈청 면역글로불린 E(Immunoglobulin E, IgE)의 증가
- ° 피부 감염에 대한 감수성 증가

2. 아토피피부염의 검사

임상적인 중증도 평가에는 신체 각 부위의 홍반(붉은 정도), 부종 및 **구진**, 긁은 상처, 태선화(‘증상’ 부분 참고)를 평가하는 ‘습진 면적 및 중증도 지수’가 널리 쓰입니다. 아토피피부염 환자의 알레르기 검사는 피부염을 악화시킬 수 있는 요인을 미리 확인하고 제거하기 위해서 시행됩니다.

1) 총 혈청 면역글로불린 E 검사

알레르기 질환과 관계가 있는 면역글로불린 E의 총량을 측정하는 것으로 아토피피부염 환자의 80% 정도에서 수치가 상승해 있습니다(외인성 아토피피부염). 하지만 이 수치가 정상이라도 아토피피부염이 나타날 수 있기 때문에(내인성 아토피피부염) 진단에는 제한적으로 이용됩니다. 총 혈청 면역글로불린 E가 높은 환자는 천식이나 알레르기 비염 등 아토피 질환을 겪고 있는 경우가 많아 유의해야 합니다.

2) 혈청 내 특이 면역글로불린 E 검사

혈액 검사를 통해 집먼지진드기, 동물 털, 꽃가루, 바퀴벌레 등 흡입을 통해 몸에 들어오는 외부 물질(항원), 또는 계란, 우유, 밀, 땅콩과 같이 음식물로 섭취되어 알레르기를 일으킬 수 있는 물질 각각에 대한 면역글로불린 E 수치를 직접 재는 방법입니다. 피부 단자 검사와 달리 약물을 복용 중이거나 피부염이 심한 상태에서도 실시할 수 있습니다. 그러나 결과가 나오는 데 시간이 걸리고 비용이 많이 듭니다. 검사 결과의 해석에는 전문가의 판단이 필요합니다.

3) 피부 단자 검사

피부 단자 검사는 간편하고 신속하게 확인할 수 있는 알레르기 항원 검사입니다. 여러 가지 항원이 들어 있는 액체를 등이나 팔에 올려 놓고 그 부위를 소독된 침으로 살짝 찌르면 15~20분 뒤에 그 부위가 부어오르며 가려운 발진이 생깁니다. 빨간 발진과 피부가 부어오른 정도에 따라 알레르기 반응의 정도를 판단하는데, 일반적으로 발진과 함께 두드러기가 3mm 이상이면 양성으로 판독합니다. 검사가 양성인 경우는 주변 상황과 환자의 과거 병력을 고려해서 유발 요인으로 판단합니다. 검사 결과의 해석에는 전문가의 판단이 필요합니다. 단자 검사는 항히스타민제 등의 약물을 복용하고 있거나 2세 미만 유아에서는 피부 반응이 약하게 나오므로 피해야 하고, 피부염이 심한 상태에는 시행하기 어렵습니다.

4) 음식물 유발 시험

음식물 알레르기과 아토피피부염이 항상 동반되지는 않지만, 유아에서 발생하는 아토피피부염이나 일반적인 치료에 반응하지 않는 경우 의심해볼 수 있습니다. 하지만 실제로 음식물이 아토피피부염의 원인인지는 의사의 세밀한 판단이 필요합니다. 환자나 보호자가 음식물의 내용과 증상 발현을 일기 형식으로 기록하면 도움이 됩니다. 대개 2~4주간 음식물 일기를 작성하는데, 약물 복용과 주위 환경의 알레르기 항원에 대한 기술도 포함해야 합니다. 병력이나 음식물 일기로 진단이 어려운 경우 음식물 유발 시험을 시행할 수 있는데, 검사 시 위험한 상황이 발생할 수 있으므로 반드시 전문의의 감독하에 시행해야 합니다.

5) 기타 검사

지속성 또는 불응성 질환이나 접촉 피부염이 의심될 경우 첩포검사를 시행합니다. 아토피 첩포검사는 지연형 과민 반응을 측정하는 검사법으로 집먼지진드기나 우유, 계란 등의 항원을 첩포로 만들어 환자의 등이나 팔에 붙인 후 48시간 이후에 피부에 생긴 습진 반응을 판독합니다. 그 외 혈액내 호산구 검사, 감염이 의심될 경우 배양 검사 등을 시행할 수 있습니다.

치료

아토피피부염은 불편함을 별로 느끼지 않는 단계에서 일상생활에 큰 어려움을 겪는 정도까지 다양한 증상을 보입니다. 따라서 환자의 병력, 중증도와 상태를 평가해 단계별 치료 전략이 필요합니다. 아토피피부염의 치료는 기본적인 치료(보습제 사용, 악화 인자 피하기), 보조적인 치료, 적극 치료 및 유지 치료로 구분할 수 있습니다.

아토피피부염의 치료 원칙은 다음과 같습니다.

1. 느긋하고 긍정적인 마음 자세

아토피피부염은 오랜 기간 동안 좋아지고 나빠지기를 반복하며, 재발을 완전히 막을 수 없습니다. 따라서 처음에는 열심히 치료를 받다가 나중에 포기하는 경우가 많습니다. 한 번의 치료로 완치하겠다는 마음보다 재발과 악화를 막기 위해 꾸준히 관리하겠다는 긍정적인 마음이 중요합니다.

2. 꾸준한 노력

증상이 좋아져도 악화 요인을 피하지 않으면 언제든지 재발할 수 있습니다. 평소에 보습제 도포와 악화 요인 제거에 꾸준한 노력을 기울여야 합니다.

3. 다른 사람의 치료법이나 소문에 빠지지 않고 개인별 치료

환자마다 유발 요인이나 악화 인자가 다르므로 다른 사람의 치료법을 무턱대고 따라하는 것은 좋지 않습니다. 자세한 병력 확인과 적절한 검사를 통해 악화 요인을 분석한 뒤 개인별 치료 방법을 올바르게 선택하는 것이 중요합니다.

4. 아토피피부염 전문가의 도움

일시적으로 좋아지는 것에 현혹되지 않고 장기적 안목으로 꾸준히 치료받고 관리해야 하므로 의사와 환자 사이의 상호 신뢰가 매우 중요합니다. 전문적인 치료와 상담이 가능한 의사를 지정해 아토피피부염 관리의 여정을 함께하는 것이 좋습니다. 필요한 경우 전문적인 심리 상담 및 전문 교육 기관에서 관리 교육을 받는 것도 도움이 됩니다.

치료-약물 치료

1. 국소 치료

1) 국소 스테로이드

국소 스테로이드는 아토피피부염의 기본 치료제로 많은 경우 효과적입니다. 국소 스테로이드는 피부 면역 세포에 작용해 이상 면역 반응을 억제합니다. 또한 가려움증을 줄이고, 염증을 가라앉혀 아토피피부염 악화와 관련이 있는 황색포도알균 수를 감소시키는 효과가 있습니다. 국소 스테로이드는 강도에 따라 가장 강한 1등급에서 제일 약한 7등급으로 구분되며, 작용 원리에 따라 연고, 크림, 로션, 용액, 겔 등 다양한 제제가 개발되어 있습니다. 치료 부위나 상태에 따라 약물의 강도, 제제를 달리해 적절히 사용해야 효과적인 치료가 가능합니다.

피부가 얇아 흡수가 잘 되는 부위에는 약한 연고를 사용하고, 두꺼운 부위에는 강도를 높여 사용합니다. 대개 음낭, 눈꺼풀 부위가 가장 흡수가 잘 되며, 얼굴-가슴, 등-팔, 다리-손등, 발등-손바닥, 발바닥 순서로 흡수됩니다. 소아나 노인은 피부가 얇아서 국소 스테로이드가 전신 흡수될 가능성이 높으므로 약한 국소 스테로이드를 사용하는 것이 좋습니다. 특히 영유아의 기저귀 부위는 밀폐되면 흡수율이 높아질 수 있으므로 유의해야 합니다.

부작용을 걱정해 너무 적은 양을 바르면 효과를 볼 수 없습니다. 적절한 양을 도포하기 위한 방법으로 손가락마디 단위를 사용합니다. 1손가락마디 단위는 5 mm 직경의 연고를 검지손가락 끝 한마디 길이만큼 일렬로 찢을 때의 용량으로, 약 0.5 g입니다. 성인에서 손(손바닥과 손등)이나 사타구니는 1단위, 얼굴, 발

은 2단위, 팔은 3단위, 다리는 6단위, 몸은 14단위(앞면 7단위, 등 7단위)를 사용합니다.

1일 1~2회 도포하며, 증상이 좋아지면 점차 도포 횟수를 줄이거나 약한 등급의 연고를 사용해 감량합니다. 국소 스테로이드제를 사용해도 증상이 좋아지지 않을 때는 약제의 강도가 너무 낮거나 양이 적은 것이 아닌지, 이차 감염이 있거나 국소 스테로이드에 대한 알레르기가 있지 않은지를 고려해야 합니다. 국소 스테로이드를 장기간 바르거나, 높은 강도의 국소 스테로이드를 사용할 경우 바른 부위의 살이 트거나 털이 많아지고, 피부 위축, 모세 혈관 확장, 스테로이드 여드름 발생 등의 부작용이 생길 수 있습니다. 그러나 보통의 아토피피부염에서 올바른 용법으로 사용한 국소 스테로이드는 대체로 안전하므로, 무조건 사용을 피하지 말고 의사의 진단과 처방대로 올바르게 사용하는 것이 좋습니다.

2) 국소 면역 조절제(국소 칼시뉴린 억제제)

국소 면역 조절제는 아토피피부염에서 일어나는 면역 세포의 이상 기능을 억제하는 효과가 있어 국소 스테로이드를 대신해 많이 사용됩니다. 국소 면역 조절제로는 타크로리무스(연고)와 피메크로리무스(크림)가 있습니다. 국소 면역 조절제의 효과는 약하거나 중간 등급의 국소 스테로이드와 비슷합니다. 장기간 사용해도 피부 위축 같은 부작용이 없어 2세 이상의 소아, 성인의 얼굴이나 목 부위처럼 피부가 약하고 얇은 부위에 효과적으로 쓸 수 있습니다. 피부가 두꺼운 손과 발, 두꺼워진 피부에는 흡수가 잘 안 되어 효과가 떨어질 수 있습니다. 급성기에는 매일 하루 2회 도포하고, 자주 재발하는 부위는 좋아지더라도 주 2회 도포해 유지 치료(전향적 치료)를 하는 방법으로 재발을 줄일 수 있습니다.

처음 도포 시 화끈거림이나 붉어짐 등의 자극 증상이 가장 흔한 부작용으로, 보통 수일간 도포하면 사라집니다. 자극 증상을 줄이기 위해 보습제와 섞어서 도포하거나, 보습제나 항염제를 바른 후에 도포할 수 있으며, 바르기 전에 냉장고에 넣어 차게 하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 약전에는 림프종이나 피부암 발생에 대한 경고문이 쓰여 있으나 인과 관계는 증명되지 않았으며, 대규모 장기 연구를 통해 현재는 국소 면역 조절제가 암 발생을 증가시킨다는 증거가 없다고 보고되었습니다.

2. 전신 치료

국소 치료제로 호전되지 않는 아토피피부염에는 사이클로스포린과 같은 전신 면역 조절제, 생물학제제, 잭(JAK) 억제제, 광선 치료 등 전신 치료를 할 수 있습니다.

1) 사이클로스포린

사이클로스포린은 전신 면역 조절제 중 일차 선택 약제로 소아에서도 사용할 수 있습니다. 그러나 고혈압, 신장 독성, 두통, 위장관계 부작용 등의 부작용이 있을 수 있으므로 주기적으로 혈압 측정, 혈구 검사, 신장 기능 검사, 간기능 검사 등을 시행해야 합니다. 1년 이상 장기 사용할 때는 주의해야 합니다.

2) 생물학제제

비교적 최근에 개발된 주사 치료제로 아토피피부염의 이상 면역 반응을 일으키는 염증 물질을 억제해 가려움증과 피부 증상 개선 효과를 보입니다. 연고 치료에 효과가 없는 중등도 이상의 아토피피부염 환자에서 사용할 수 있습니다. 생물학제제 중 현재 아토피피부염에서 승인된 약제는 두펄루맙과 트랄로키누맙이 있습니다.

3) 잭(JAK) 억제제

생물학제제와 함께 비교적 최근에 개발된 경구 약물로 아토피피부염의 병인에 관여하는 염증 물질의 작용을 차단합니다. 연고 치료제에 효과가 없는 중등도 이상의 아토피피부염에서 가려움증과 피부 증상 개선에 도움이 됩니다. 현재 우리나라에서 승인된 약물은 바리시티닙, 우파다시티닙, 아브로시티닙이 있습니다. 복용 전에 가슴 방사선 사진 촬영과 혈구 수, 신기능 및 간기능, 결핵 및 간염 선별을 위한 피검사가 필요하며, 약물 복용 중에도 주기적인 피검사가 필요합니다.

4) 기타 면역 조절제

메토틱세이트, 아자티오프린, 마이코페놀레이트 모페틸 등은 다른 치료에 반응하지 않는 아토피피부염 환자에게 효과를 보일 수 있습니다. 메토틱세이트는 주 1~3회 투약하므로 복용이 편리한 장점이 있으나 효과가 비교적 늦게 나타나고, 부작용으로 오심과 같은 위장관 증상, 간 독성, 골수 억제 등이 발생할 수 있어 주의해야 합니다.

5) 항히스타민제

아토피피부염의 주증상인 가려움증을 줄이기 위해 항히스타민제를 복용하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 피부를 긁거나 자극하면 가려움증을 일으키는 물질이 더 많이 생기고, 이로 인해 피부를 다시 긁고 피부염이 악화되는 악순환이 반복됩니다. 항히스타민제는 졸리거나 집중력이 떨어지는 문제가 생길 수 있으므로 가려움증이 심한 저녁이나 자기 전에 복용하기도 합니다.

6) 전신 스테로이드제

스테로이드제를 복용하거나 주사하면 빨리 좋아질 수 있지만, 약물 중단할 경우 반동(리바운드) 현상에 의해 증상이 악화될 수 있습니다. 전신 스테로이드의 부작용은 고혈압, 당뇨병, 위장 장애, 체중 증가, 골다공증, 피부 위축, 녹내장, 쿠싱 증후군 등입니다. 따라서 다른 치료에 반응하지 않거나 심한 급성 악화 시에 한해 단기간만 사용해야 합니다.

7) 이차 감염 치료

아토피피부염 환자의 피부는 피부 장벽 기능의 손상으로 정상인보다 세균이나 바이러스, 진균에 쉽게 감염되고, 이러한 이차 피부 감염은 아토피피부염을 악화시킬 수 있습니다. 세균에 감염되면 항생제 연고를 바르고, 심한 경우 경구용 항생제를 써야 합니다. 그러나 항생제를 장기적으로 쓰면 항생제 내성과 감작을 일으킬 수 있습니다. 바이러스에 의해 포진 모양 습진이 생긴 경우 항바이러스제로 즉시 치료하는 것이 좋습니다. 일부 진균 감염은 성인의 두피, 얼굴, 목 등에 발생하는 아토피피부염의 악화와 관련이 있다고 보고되었습니다.

치료-비약물 치료

1. 피부 보습

아토피피부염 환자의 피부는 건조하고 피부 장벽 기능이 떨어져 있으므로 적절한 보습은 치료의 기본입니다. 보습제는 피부에 수분을 공급하고 피부 장벽 기능을 회복시키며 증상을 완화해 국소 스테로이드 사용량을 줄이고 재발을 예방하는 효과가 있습니다. 보습제는 피부염이 없을 때도 하루 2~3회 이상 발라야 하며, 피부염이 발생하거나 건조할 때는 하루 4~5회 충분한 양을 바르는 것을 권장합니다(성인 기준 1주에 250 g 이상 사용). 염증이 있고 피부 각질층이 손상된 부위는 보습제를 발라도 보습이 잘 안 되므로 처방받은 치료제와 함께 사용하는 것이 좋습니다. 씻지 않고 발라도 되지만, 땀이나 오염을 깨끗이 씻고 바르는 것이 더 좋습니다.

보습제는 수분 함량에 따라 로션, 크림, 연고로 나뉩니다. 로션보다 크림, 연고가 보습 기능이 더 뛰어납니다. 여름에는 수분이 많은 로션을 사용하고, 가을이나 겨울에는 크림 또는 연고를 사용하면 좋습니다.

최근 유럽 치료 지침에서는 2세 이하에서 땅콩, 귀리, 밀과 같은 잠재적인 알레르기 항원 단백질이 들어 있는 보습제를 피하라고 권고했습니다. 보습제 성분 중 일부 보존제나 향료 등은 자극이 될 수 있으므로 주의해야 합니다. 보습제는 피부 상태와 생활 습관, 계절, 개인의 취향 등에 따라 적절히 선택해야 합니다.

2. 수성 밀폐 요법(wet wrap)

아토피피부염이 갑자기 심해진 경우 수성 밀폐 요법이 도움이 될 수 있습니다. 하지만 감염의 위험성이 있을 수 있으므로, 의사와 상의 후에 시행하는 것이 좋습니다. 간단한 치료 방법은 다음과 같으며, 자세한 동영상은 대한아토피피부염학회 홈페이지에서 확인 가능합니다(https://youtu.be/_WlbDF8e3NM).

- (1) 준비물: 보습제, 국소 스테로이드 또는 항염 크림, 미지근한 물, 거즈나 패드/얇은 수건/붕대(면 내의나 조이는 의복으로 대체 가능), 대야 또는 욕조
- (2) 목욕 후 보습제 또는 국소 스테로이드/항염 크림을 바릅니다.
- (3) 미지근한 물에 적신 거즈나 붕대로 병변 부위를 감쌉니다.
- (4) 건조 상태의 마른 거즈나 자극이 없는 면 재질의 옷으로 감쌉니다.

3. 광선 치료

아토피피부염 환자는 대부분 여름에 증상이 좋아지는데, 이것은 태양 광선 속에 있는 자외선과 관련이 있습니다. 자외선은 아토피피부염을 일으키는 염증 세포들의 기능을 억제할 수 있습니다. 광선 치료에 쓰이는 자외선은 자외선A(파장 320~400 nm), 자외선B(파장 290~320 nm), 좁은띠(단파장) 등이 있으며, 국내에는 좁은띠 자외선B의 치료 장비가 널리 쓰입니다. 특히 동반 질환 등으로 다른 전신 치료를 사용할 수 없는 환자나 임신부, 중등도 이상의 증상을 보이는 환자에서 유용합니다. 하지만 치료 효과를 보는 데 시간이 걸리고, 매주 2~3회 규칙적으로 치료해야 하는 불편함이 있습니다. 흔한 부작용으로 국소 홍반, 따가움, 가려움증, 피부 화상 등이 있을 수 있습니다.

4. 항원 특이 면역 치료

면역 치료는 집먼지진드기, 꽃가루, 동물, 곰팡이 및 벌이나 개미 같은 절지류 알레르기 항원에 대해 과민성이 있는 경우 고려해볼 수 있습니다. 아토피피부염의 면역 치료가 가장 우수한 효과를 보이는 항원은 집먼지진드기입니다. 따라서 병력 조사, 피부 반응 검사, 혈액 검사를 시행해 집먼지진드기에 대한 과민성이 확인된 경우 면역 치료를 시행할 수 있습니다. 아토피피부염의 면역 치료는 피하 면역 요법과 설하 면역 요법이 있습니다.

5. 보조 치료(유산균, 필수 지방산, 비타민 D)

1) 유산균(프로바이오틱스, 프리바이오틱스)

프로바이오틱스는 장내 미생물 균형 개선을 통해 숙주인 사람에게 유익한 역할을 하는 균주를 말합니다. 프리바이오틱스는 장내의 유익한 균을 증식시키는 인자로 올리고당, 식이 섬유 등이 있습니다. 여러 연구에서 유산균제제가 아토피피부염 완화에 효과가 있다고 보고되었으나 아직 근거가 명확하지는 않습니다. 출생 전후에 산모와 아기가 유산균제제를 복용하면 아토피피부염 예방 효과가 있다는 연구 결과가 있습니다.

2) 필수 지방산

아토피피부염은 피부 내 필수 지방산 대사 이상을 동반합니다. 감마리놀렌산이 함유된 달맞이꽃 종자유를 복용하면 필수 지방산 보충에 도움이 됩니다. 아직 여러 연구에서 증명된 것은 아니지만 부작용이 거의 없으므로 보조 치료로 사용될 수 있습니다.

3) 비타민 D

아토피피부염 환자에서 비타민 D가 면역 반응을 정상화시키고 아토피피부염 개선에 효과를 보인다는 연구 결과도 있으나 효과가 없다는 보고도 있으며, 명확한 기전은 밝혀지지 않은 상태입니다.

합병증

1. 눈과 주변 피부의 이상

눈꺼풀 피부의 염증과 자극으로 인해 눈꺼풀 피부염이 발생할 수 있습니다. 만성적인 자극과 염증으로 눈 주위 피부 주름이 뚜렷해지며, 염증 후 색소침착으로 눈 주위가 검게 변할 수 있습니다. 눈썹을 반복해 긁거나 문지르면 바깥쪽 눈썹이 빠지기도 합니다. 그 밖에 각결막염, 백내장이나 원추 각막, 드물게 망막 박리, 녹내장 등도 발생할 수 있습니다. 눈을 자주 긁거나 비빌 때 생기는 외상과 안과 질환의 관련성이 있을 수 있으므로 반복적인 마찰을 피해야 합니다.

2. 피부 감염

아토피피부염 환자는 피부 면역 이상, 피부장벽 손상으로 인해 세균, 바이러스, 곰팡이(진균) 등에 의한 피부 감염이 정상인에 비해 높은 빈도로 발생합니다. 세균 감염으로는 황색포도알균 감염이 가장 흔합니다. 황색포도알균은 정상인의 피부에도 존재하지만, 아토피피부염 환자 피부에는 90% 이상 존재합니다. 급성 아토피피부염에서 황색포도알균의 활동이 활발해지면 물집, 고름집이 생기고, 진물이 나며, 딱지가 앉는 농가진이 발생할 수 있습니다. 바이러스 감염으로는 단순 포진 바이러스가 포진 모양 습진 혹은 카포시 수두 모양 발진을 일으킬 수 있습니다. 단순 포진 바이러스는 피곤하거나 감기 후에 입 주위 물집을 일으키는 흔한 병원체입니다. 다른 바이러스 질환으로 전염성 물렁종(물사마귀), 사마귀 등이 잘 동반됩니다. 아토피피부염 환자에서는 피부 진균 감염이 흔하며, 일부 곰팡이는 성인의 두피, 얼굴, 목 등에 발생하는 아토피피부염의 악화와 관련이 있습니다.

3. 손 피부염

아토피피부염 환자는 손 피부염이 흔히 발생하며, 물을 자주 접촉하거나 비누, 세제 등을 과도하게 사용하면 악화될 수 있습니다.

4. 벗음 피부염

드물게 피부의 발적, 비늘, 진물, 딱지가 광범위하게 나타나면서 발열이나 림프절이 커지는 증상이 나타납니다. 심한 아토피피부염 치료를 위해 장기간 사용한 전신 스테로이드를 갑자기 중단했을 때나 피부 감염 시에 발생할 수 있습니다.

위험요인 및 예방

아토피피부염의 관리 시에는 악화 인자를 피하는 것이 중요합니다. 아토피피부염의 악화 인자는 기후나 공기 오염 외에도 의복, 집먼지진드기, 화장품, 음식이나 식품, 신체적 혹은 정신적 스트레스 등을 들 수 있는데, 나이, 주변 환경, 생활 습관에 따라서 많은 차이가 있습니다.

1. 자극원

아토피피부염 환자는 비누와 세제, 화학 약품, 모직과 나일론 의류, 비정상적인 기온이나 습도 등에 의해 피부염이 악화될 수 있습니다. 따라서 생활 습관 관리가 필요하며, 기계적 혹은 화학적 자극(땀, 털, 산, 향신료, 표백 제품)이나 유기 용매 등은 피하는 것이 좋습니다.

2. 음식 알레르기 유발 물질

영유아 아토피피부염 환자 중 치료에 반응을 보이다가 치료를 중단하면 바로 증상이 심해지는 경우 음식 알레르기를 의심해볼 수 있습니다. 음식 알레르기의 주원인은 우유, 계란, 땅콩이며 그 외에 콩, 밀, 생선 등이 있습니다. 음식에 의한 아토피피부염 악화는 개인차가 많으므로 아토피피부염이 있다고 해서 알레르기 유발 음식을 무조건 제한하는 것은 바람직하지 않습니다. 그러한 음식들은 성장에 꼭 필요한 영양분을 함유하고 있으므로 정확한 근거 없이 제한하면 영양 결핍, 성장 장애가 발생할 수 있습니다. 따라서 반드시 의사의 진료를 받고, 알레르기 검사와 병력 확인 등을 통해 확인된 음식물만 제한해야 합니다. 필요한 경우 음식물 일기를 통해 아토피피부염의 악화를 일으키는 음식물을 추적하는 방법도 도움이 됩니다. 음식물 알레르기나 아토피피부염을 예방하기 위해 임신 중에 음식물을 제한하는 것은 권장하지 않습니다.

3. 흡입 알레르기 유발 물질

아토피피부염 환자에서 가장 흔하게 양성 반응을 보이는 흡입 알레르기 유발 물질은 집먼지진드기입니다. 온도와 습도 조절, 집먼지진드기 방지용 매트리스 커버 사용, 집먼지진드기 제거 청소법을 이용해 조절할 수 있습니다. 그 외 꽃가루, 동물 털 등도 아토피피부염을 악화시킬 수 있습니다.

4. 접촉 항원

아토피피부염 환자는 니켈이나 국소 치료제 성분 등에 대한 접촉 피부염의 빈도가 높습니다. 따라서 치료에 잘 반응하지 않으면 철폐검사를 이용해 접촉 피부염이 동반되었는지 확인하고, 확인된 물질에 접촉하지 않아야 합니다.

생활습관 관리

아토피피부염을 예방하기 위해서는 생활 습관을 관리해야 합니다.

1. 목욕

피부에 묻어 있는 땀, 향원, 세균, 자극성 물질 등을 씻어 피부를 청결하게 합니다. 목욕은 피부에 수분을 직접 공급하고 바르는 약물의 흡수를 촉진하기도 합니다. 하지만 목욕을 너무 자주 하면 피부 지질 같은 자연 보습 물질을 감소시켜 피부가 오히려 건조해질 수 있습니다. 때밀이 수건으로 피부에 과도한 자극을 주면 피부의 가장 바깥에 있는 각질층이 떨어져 나가며, 물속에 몸을 오래 담그면 각질층 소실이 빨라집니다. 또한 피부를 보호하는 지질층은 미지근한 물보다 뜨거운 물에서 더 쉽게 손상됩니다. 27~30도의 미지근한 물로 하루 1회 10~20분 이내로 간단하게 샤워하거나, 피부를 약간 물에 불릴 정도로만 욕조에 몸을 담그는 것이 좋습니다.

비누를 과도하게 사용하면 지질층이 손상되고 피부가 건조해지지만, 물로만 씻는 것도 세균이나 오염물을 충분히 제거하지 못하므로 적절한 비누 사용이 중요합니다. 약산성에서 중성의 저자극성 액상 비누가 고형 비누보다 좋습니다. 목욕 후에 그냥 물기가 마르도록 방치하면 피부가 건조해질 수 있으므로, 피부를 수건으로 톡톡 두드려 닦은 후 물기가 마르기 전 3분 이내에 보습제를 바릅니다.

2. 의복

의복은 모직이나 나일론보다 부드러운 질감의 면이나 견이 좋습니다. 새 옷은 세탁한 뒤에 입고, 세탁 시에는 세제가 남지 않도록 물로 여러 번 헹구는 것이 좋습니다.

3. 손톱

굵으면 더 가려워지므로 손톱을 짧게 유지합니다. 유아는 손에 장갑을 끼워 재우는 것도 도움이 됩니다.

4. 운동

스트레스 해소를 위한 가벼운 운동은 좋으나, 지나친 발열이나 발한을 일으키는 격렬한 운동은 피하는 것이 좋습니다. 운동 후 땀은 바로 닦아줍니다.

5. 정서적 안정

아토피피부염 환자는 피부 상태로 인해 분노, 불안, 좌절감 등을 느낄 수 있습니다. 스트레스를 느끼는 정도는 개인차가 있지만, 정신적 스트레스는 아토피피부염의 악화 요인으로 작용합니다. 스트레스가 생길 때는 믿고 의지할 수 있는 가족이나 친구와 대화하고 격려받는 것이 도움이 됩니다. 스트레스가 심하다면 정신건강의학과의 적절한 상담 및 치료를 받는 것이 도움이 될 수 있습니다.

6. 온도와 습도

실내는 적절한 온도(20~22도)와 습도(45~55%)를 유지하고, 급격한 온도 변화를 피해야 합니다.

자주하는 질문

Q. 아토피피부염은 왜 생기나요?

A.

아토피피부염은 유전적인 소인이 있으나 면역학적인 측면, 피부장벽 기능 이상, 환경적 요인이 복합적으로 작용해 발생합니다.

Q. 아토피피부염이 있으면 다른 알레르기 질환도 잘 생기나요?

A.

아토피피부염이 있으면 성장하면서 다른 알레르기 질환이 동반될 수 있는데, 이를 ‘알레르기 행진’이라고 합니다. 아토피피부염, 천식, 알레르기 비염 등이 순차적으로 나타날 수 있습니다.

Q. 아토피가 있는 아이는 달걀, 우유, 밀가루를 먹지 말아야 하나요?

A.

아토피가 있는 영유아는 음식물 알레르기의 빈도 역시 높지만, 모든 아토피피부염 환자가 음식물을 제한해야 하는 것은 아닙니다. 특정 음식물을 먹고 2시간 이내에 두드러기 등의 급성 알레르기 증상이 나타난다면 음식물과 연관이 있을 가능성이 높습니다. 이때는 원인 음식을 피하고 알레르기 검사를 통해 확인해야 하지만, 섭취 후 특별한 증상이 나타나지 않는 음식물을 제한할 필요는 없습니다.

Q. 아토피피부염은 자라면서 사라진다고 하던데 사실인가요?

A.

영유아기에 시작한 아토피피부염은 대개 경증이며, 나이가 들면서 완화되는 경향을 보입니다. 그러나 성인기에 재발하거나 지속되는 경우도 있습니다.

Q. 아토피피부염 환자에서 보습제는 어떻게 사용해야 하나요?

A.

보습제는 손상된 피부 장벽으로 인해 건조한 피부에 도움이 되므로 아토피피부염 환자는 규칙적으로 사용하는 것이 좋습니다. 목욕 후 물기가 남아있는 상태에서 전신에 바르고, 목욕 후가 아니라도 피부가 건조한 경우 수시로 도포하는 것이 좋습니다. 습도가 높은 여름에는 비교적 가벼운 로션 타입이, 건조한 겨울에는 수분 밀폐 효과가 높은 크림 타입이 좋습니다.

Q. 아토피피부염 아이가 있는 집안의 환경 관리는 어떻게 해야 하나요?

A.

실내 온도는 20-22도, 습도는 45-55% 정도로 조절합니다. 환기를 자주 해서 집안의 먼지나 유해 물질을 배출하는 것도 중요합니다. 집먼지진드기에 의해 알레르기 증상이 악화될 수 있으므로 집먼지진드기가 잘 서식하는 헝겊 제품이나, 카펫, 커튼은 사용하지 않는 것이 좋습니다. 침구류는 60도 이상의 뜨거운 물로 세탁해 집먼지 진드기를 제거합니다. 동물의 털에 알레르기 반응이 있다면 반려동물을 키우지 않는 것이 좋습니다.

Q. 아토피피부염 환자의 약물치료는 어떻게 하나요?

A.

경증 환자는 환경 관리와 보습제만으로 호전되는 경우도 있지만, 증상이 지속되면 약물을 써야 합니다. 먼저 전문의의 진찰을 통해 환자의 중증도를 파악하고, 증상이 심하지 않다면 연고를 사용해서 염증과 가려움을 완화합니다. 연고를 바른 후에도 증상이 지속된다면 먹는 약, 주사제 등을 사용할 수 있습니다. 약물의 선택은 전문의와 상의하는 것이 좋습니다.

Q. 아토피환자에서 스테로이드 치료제를 사용해도 되나요?

A.

부작용을 우려해 스테로이드 치료제를 무조건 피하려는 환자나 보호자가 있습니다. 하지만 스테로이드는 아토피피부염의 일차 치료제로 중요한 역할을 담당합니다. 나이나 피부 병변의 부위에 따라 적절한 강도의 스테로이드 연고를 사용하면 부작용 없이 가려움과 염증을 빠르게 없앨 수 있습니다. 스테로이드 연고를 발라 증상이 호전된 후에는 스테로이드가 들어 있지 않은 연고를 유지 치료로 사용할 수 있습니다. 먹는 스테로이드는 부작용 위험이 크지만, 전문의의 판단에 따라 꼭 필요한 경우 단기간(2주 이내) 처방하는 경우가 있습니다. 적절한 스테로이드 치료제의 선택은 전문의의 판단에 따르는 것이 좋습니다.

참고문헌

1. 고현창 등. (2024). 한국아토피피부염치료 가이드라인. 대한아토피피부염학회.
2. 김진우, 이광훈. 아토피피부염. 군자출판사. 2017. ISBN: 9791159552410.
3. 대한피부과학회 교과서 편찬위원회. 피부과학 제7판. 맥그로힐에듀케이션코리아 유한회사. 2020. ISBN: 9791132105589.
4. 한태영, 나찬호, 이지현 등. 아토피피부염의 치료. 대한피부과학회지 2018;56(10):581-593.

5. 아토피피부염 교육자료 1-8. 대한아토피피부염학회.

